

临床思维思维训练

临床医生思维方法

快速思维（非分析型思维）

病例库的储存

慢速思维（分析性思维）

通常从解剖-病理-生理角度解释相关症状和体征，推理得出解决方案 eg.止血带扎在中1/3，桡神经走行在浅表；不扎在前臂，因为前臂骨间膜中有丰富的侧枝循环

汇报病情（逻辑思维能力）--必要信息--问诊--鉴别诊断

例1. 用精炼的语言汇报病情

关节疾病--大关节/小关节--单侧/双侧--固定的/游走性的“晨僵”--清晨关节僵硬“进行性/渐进性加重”

晨僵 [百度百科](#)

晨僵是指患者在清晨醒后关节部位出现的僵硬感，主要表现为关节活动受限及酸胀不适，其持续时间与滑膜炎的严重程度呈正相关。该症状常见于类风湿关节炎、强直性 ...

中年女性，因慢性小关节中重度晨僵，进行性加重就诊

例2. 鉴别诊断能力

急诊病人接诊查因

青年男性，突发晕厥。求晕厥可能的原因？

1. 神经源性：中暑--血管迷走性相关
2. 内分泌：低血糖--吃早饭了吗
3. 心源性：心脏病--心悸胸痛--晕厥前有无其他症状
4. 神经源性：癫痫发作--倒地有无大小便失禁，自主运动，有无其它症状
5. 创伤性：撞击--颈动脉窦--有无外伤冲撞

青年男性，晕厥伴呼吸苦难，端坐呼吸。

1. 心律失常？主动脉狭窄？
2. 肥厚性心肌病？肺栓塞？

--以前就有吗？多久了？多没有发展变化？ 答：近一年自觉运动耐力下降？

之前就诊经历？用药史？ 答：无心悸，有胸痛。

是否能排除肺栓塞？ 答：劳力性心绞痛？肺栓塞？

长途旅行？长期卧床？有没有查出血栓肿瘤？（无）

主动脉狭窄？肥厚梗阻性心肌病？

以前身体好吗？有没有得过什么疾病？--心瓣膜病？主狭？

--查体？（胸骨右缘第二肋间4/6期喷射样杂音，杂音没有变化是主狭，有变化是梗阻性心肌病）

--辅助检查？（超声心动图）

总结

青年男性，因突发短暂自限性晕厥伴进行性呼吸困难，阵发性胸痛收入我院。

例3.慢性咳嗽

< 3w急性

1. 感染性？
2. 慢性高血压+慢性咳嗽（吃什么药--ACEI--停药）
3. 消化：（吃不吃夜宵--反酸/咳嗽）
4. 咳嗽变异性哮喘（--肺功能检查--抗炎，舒张血管）

例4.

Hyperpyrexia高热 两次B超阴性--History-taking--隔逆--膈下脓肿

例7.腹痛查因

胆囊不可移动回声影（胆囊息肉） 腹痛：

1. 心源性：老年有高血压/血脂高：早期心肌肥厚可能没有变化--隔1小时心肌酶谱+心电图
2. 妇科：45岁：停经史/宫外孕？老年：卵巢扭转
3. 输尿管/肾结石
4. 十二指肠
5. 青光眼：腹部查体阴性，但视野缺失--消化科使用解痉药会加重病情

例8.诊疗思路

1. 不明原因发热首选--全身浅表淋巴结变化
2. 颅脑扫描--对称--类似转移瘤高密度影
3. 考虑CA找原发病灶
 1. PET-CT
 2. History-retaking
 1. 特殊地方/特殊进食--寄生虫，何生人？

例9.腹泻就诊--最终甲亢

例10.急救技能的临床思维

开放性和闭合性伤 骨盆骨折--红骨髓--大出血 股骨头骨折--黄骨髓--警惕栓塞 大量出血--血型/备血 + 补液
/血常规数据+常用生命体征数据/ 白细胞计数： $(4-10) \times 10^9$ IgG:曾经感染过，IgM现在在感染